



Doctooome

Analyse Data du questionnaire Diabète de Type 2

Réalisé par : Nour Benghouma

SEPTEMBRE 2026



Sommaire

01 Contexte & objectifs

02 Données & méthodologie

03 Qualité & préparation des données

04 Analyse du parcours utilisateur

05 Analyse des canaux d'acquisition

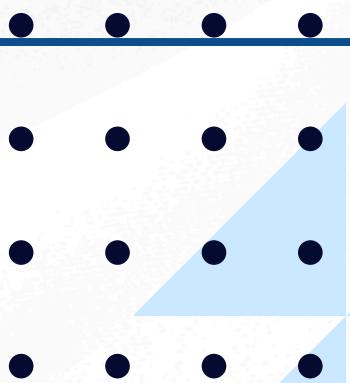
06 Analyse du comportement & des résultats

07 Principaux enseignements

08 Questions ouvertes & données complémentaires

09 Suivi recommandé sur 12 mois

10 Conclusion & Recommandations





1-Contexte & objectifs

Contexte

Doctoome a lancé une landing page permettant aux visiteurs de répondre à un questionnaire de sensibilisation au diabète de type 2.

Le parcours comporte :

Visite → Démarrage → 5 questions → Complétion → Catégorie de résultat

Objectif de l'analyse

Comprendre le comportement des utilisateurs, identifier les principales ruptures du parcours et dégager les indicateurs à suivre pour améliorer la performance et la qualité des données.

2-Données & méthodologie



Table	Volume	Contenu
Visiteurs	20 000	Profil utilisateur
Sessions	26 000	Acquisition & navigation
Événements	195 816	Parcours utilisateur
Réponses	68 460	Réponses aux questions
Résultats	11 357	Catégorie finale
Questions	5	Structure du questionnaire

- **Approche**

Exploration → Contrôle qualité → Nettoyage → Analyse → Visualisation → Recommandations

- **Outils**

Python · Pandas · SQL · DuckDB · Matplotlib



3-Qualité & préparation des données

01

Contrôles effectués

- Valeurs manquantes
- Doublons
- Unicité des identifiants
- Cohérence des catégories

02

Standardisation

Genre

- F / Female → female
- M / Male → male

Régions

- Harmonisation des différentes écritures d'une même région.

03

Déduplication des réponses

68 460 réponses brutes

↓

67 763 réponses après nettoyage

- 697 doublons supprimés

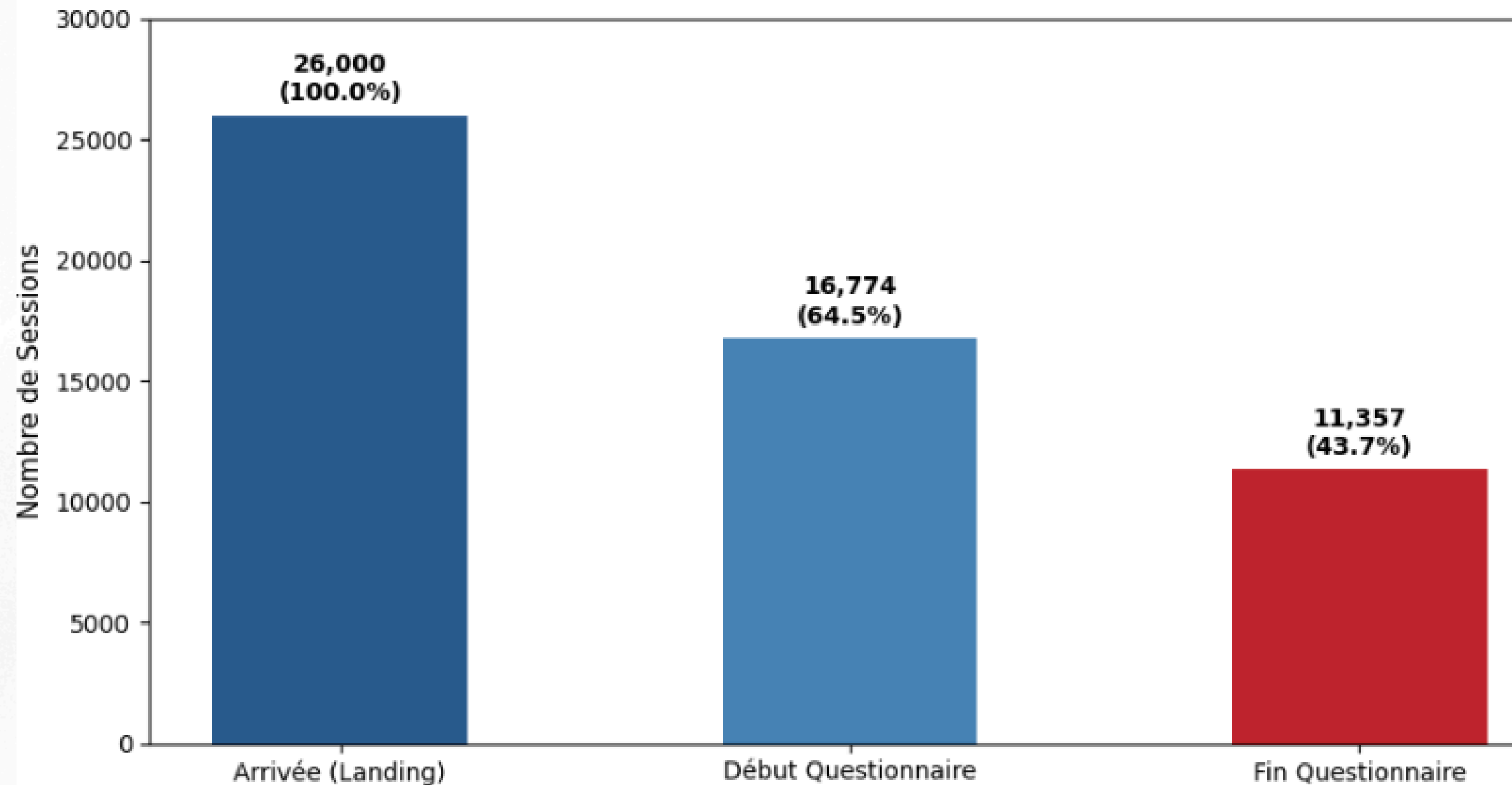
```
ROW_NUMBER() OVER (  
    PARTITION BY session_id, question_number  
    ORDER BY answered_at DESC  
)
```





4-Analyse du parcours utilisateur

Funnel de Conversion Général (26 000 Sessions)

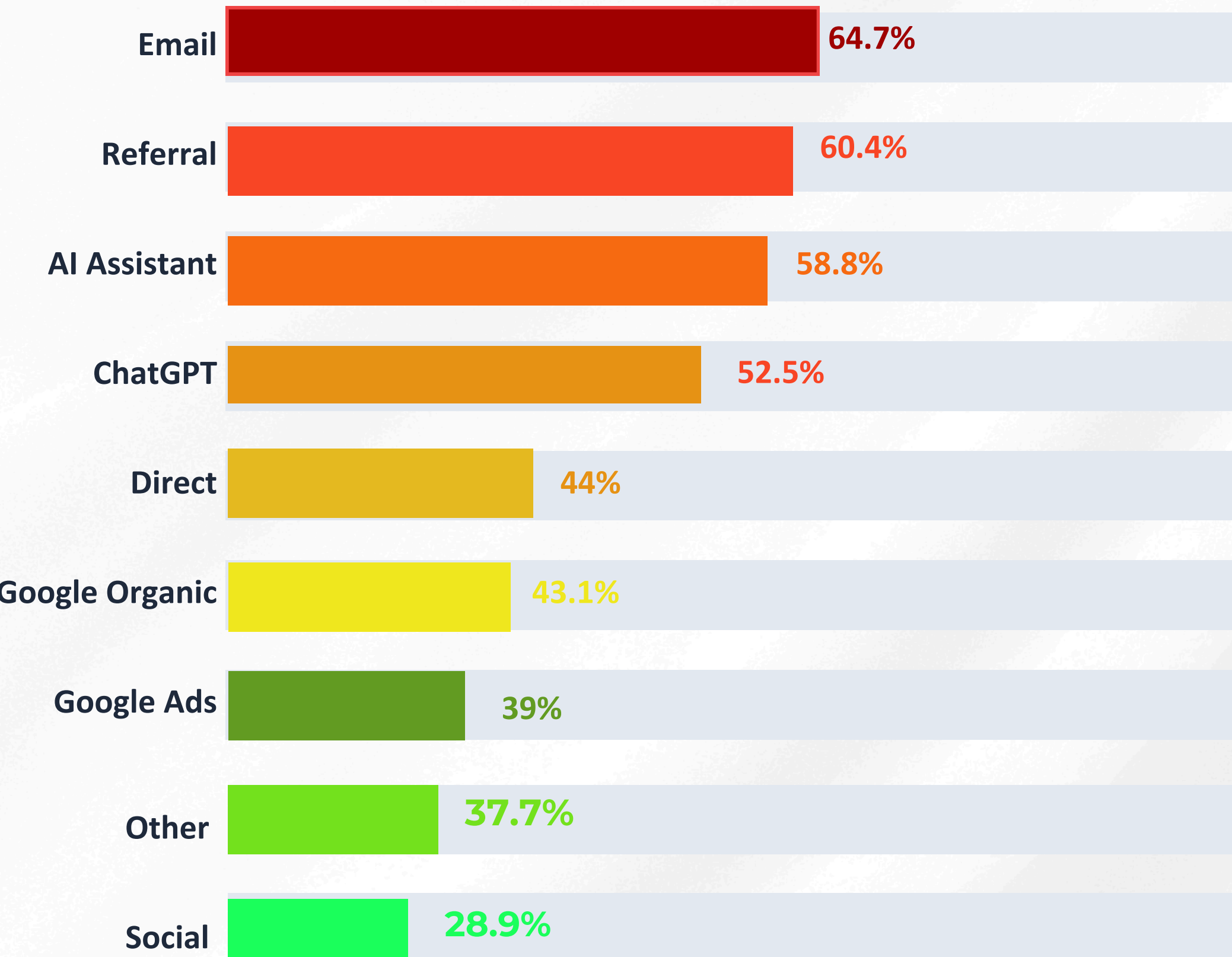


Principales ruptures :

- **Landing → Démarrage:**
-35,5 % (soit 9 226 visiteurs perdus sans interaction)
- **Q4 → Q5**
-13,5 % (décrochage avant la question finale)



5-Analyse des canaux d'acquisition

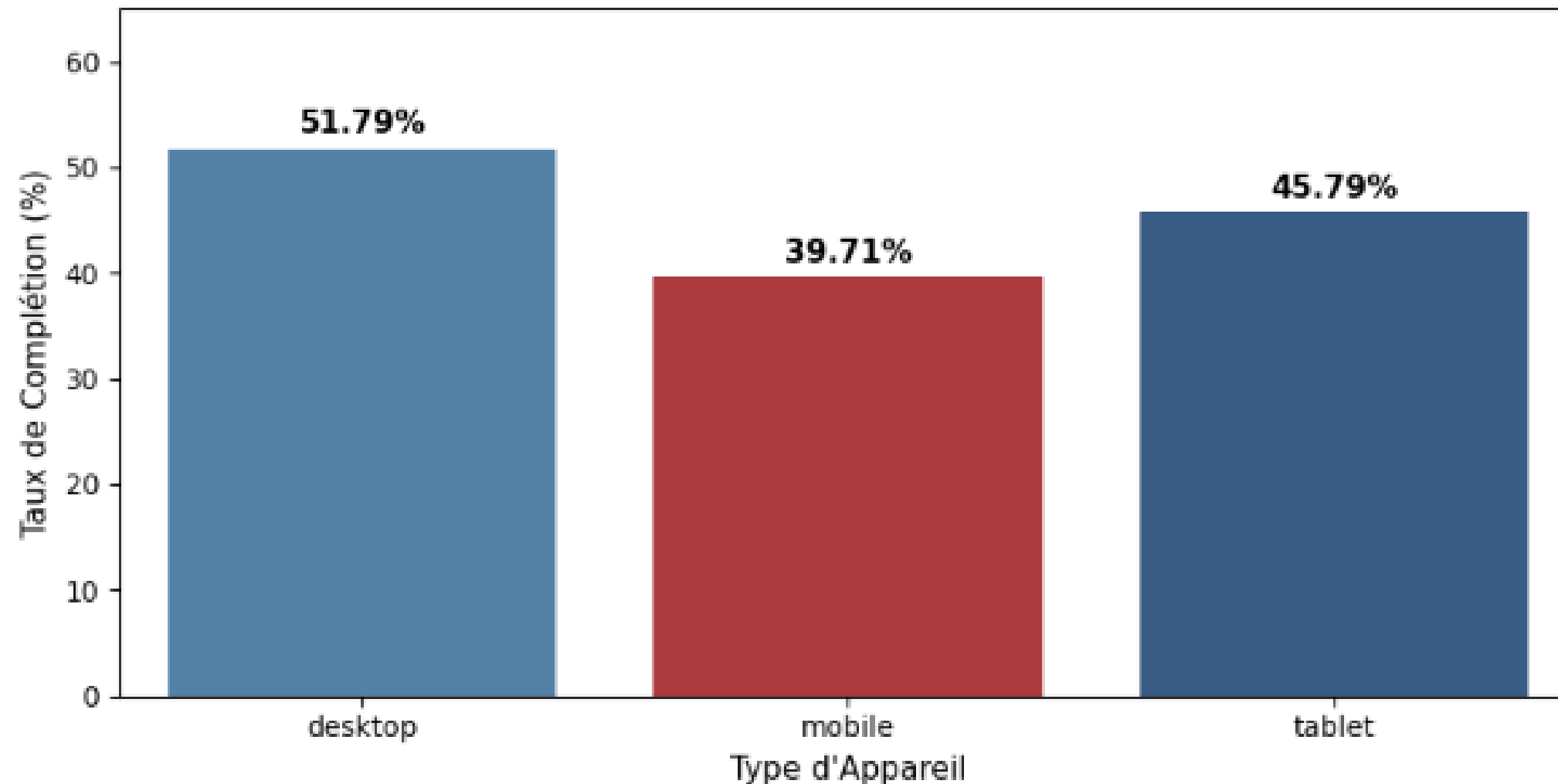


- **Email & Referral** : Taux de complétion record (60-65%), mais audience majoritairement saine (~72% de **no_current_indication**).
- **Google Ads** : Complétion moyenne (39,0%), mais c'est le canal le plus performant pour la mission médicale : 45,4% des répondants y sont détectés à risque (**possible_risk**) ou diagnostiqués (**declared_diagnosed**), soit 2 fois plus que le Social



6-Analyse du comportement & des résultats

Taux de Complétion du Questionnaire par Appareil (%)



Résultats du questionnaire:

69,0 % Aucun indice actuel
20,0 % Risque potentiel
10,9 % Diagnostic déclaré

- Q4 — Activité physique :
58,0 % des utilisateurs classés **possible_risk** déclarent une activité physique « rarement ou jamais », contre 13,3 % pour **no_current_indication**.

Ces écarts sont observés, mais leur cause nécessite des données comportementales complémentaires



7-Principaux enseignements

Le premier enjeu est l'entrée dans le questionnaire

35,5 % des sessions ne démarrent pas le parcours.

Une friction apparaît entre Q4 et Q5

13,5 % des utilisateurs sont perdus entre ces deux étapes.

Friction Mobile critique sur 65% du trafic (-12 pts vs Desktop)

La majorité du trafic est mobile, mais le taux de complétion est inférieur au desktop.

Les canaux ont des comportements différents

Les taux de complétion varient fortement selon la source d'acquisition

L'analyse permet d'identifier les zones de friction, mais des données supplémentaires sont nécessaires pour en expliquer les causes.



8-Questions ouvertes & données complémentaires

1. **Cause du décrochage à la Q5 .**
 2. **Coût d'Acquisition Client (CAC) & ROI .**
 3. **La nature exacte de la friction mobile.**
 4. **Parcours aval des patients .**
- 

Données supplémentaires à collecter:

1. Télémétrie UX granulaire : Temps passé par question (time_spent_per_step), suivi des erreurs JavaScript et du scroll.
2. Conversion post-questionnaire : Clics sur le bouton "Prendre RDV avec un médecin", taux de conversion en consultation effective.
3. Données marketing détaillées : CPC, mots-clés Google Ads pour affiner le ciblage d'intention.
4. Consentement de relance : Possibilité de relancer par email les profils à risque n'ayant pas consulté



9-Suivi recommandé sur 12 mois

Dashboard & Alerting opérationnel

- Suivi hebdomadaire des KPIs / Alertes automatisées en cas d'anomalie après une mise en production..

Programme d'A/B Testing Continu

- Test Landing.
- Test Mobile.

Surveillance du Data Drift & Saisonnalité

- Monitorer l'évolution de la distribution de l'âge et des régions au fil des saisons.
- Anticiper le pic annuel .

KPI Métier Santé & Business

- Coût par Patient à Risque Orienté.
- Mesurer la fidélisation à la plateforme.

Conclusion & Recommandations

Le questionnaire a prouvé sa pertinence clinique (+10 ans d'âge moyen chez les profils à risque) ; le défi des 6 prochains mois est désormais UX et opérationnel pour transformer ces visiteurs en patients suivis.

- UX / Produit : Alléger la Landing Page et fluidifier le parcours Mobile.
- Acquisition : Réallouer les budgets vers Google Ads .
- Santé / Métier : Connecter le test à la prise de rendez-vous sur Doctoome.



Merci pour votre attention.